

Sepse · qSOFA e bundle inicial

Sepse é disfunção orgânica ameaçadora por infecção. Em prova, priorize reconhecimento rápido, culturas antes do antibiótico e reposição volêmica precoce no choque.

Definição útil

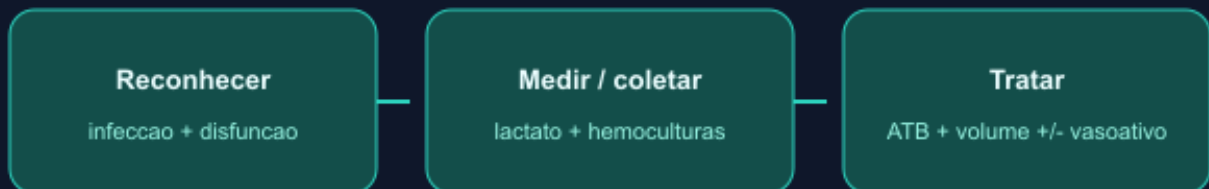
Lembre - Definição útil

Sepse "H infecção + aumento agudo do SOFA "e 2. Choque séptico: sepsse + vasopressor para PAM "e 65 mmHg e lactato > 2 mmol/L após volume adequado.

Fluxo clássico de prova: reconhecer !' medir/coletar !' tratar na 1ª hora.

Bundle da 1a hora

Suspeita de sepsse / choque septico



qSOFA (triagem à beira do leito)

- FR "e 22 irpm
- PAS "d 100 mmHg
- Alteração do nível de consciência
- "e 2 pontos: investigar sepsse e disfunção — não fecha diagnóstico sozinho

Bundle inicial (visão de prova)

Passo | Conduta

Lactato | Dosar e repetir se elevado

Culturas | Hemoculturas ("e 2 pares) antes do ATB, sem atrasar

Antibiótico | EV de amplo espectro na 1ª hora se choque/sepsse grave

Volume | Cristalóide ~30 mL/kg se hipotensão ou lactato alto

Vasopressor | Noradrenalina se PAM < 65 após volume

Armadilha de prova

Atencao - Armadilha de prova

Não atrase antibiótico para 'esperar o resultado da cultura'. Colete rápido e inicie ATB empírico guiado pelo foco e epidemiologia local.

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

qSOFA, SOFA e o Hour-1 Bundle são o núcleo da sepsse nas provas — reconhecimento rápido e reanimação precoce.

Não diagnostica sepse sozinho; dispara avaliação de disfunção orgânica (SOFA).

qSOFA (3 itens)

Bedside; ≥ 2 = alto risco

FR ≥ 22 irpm	1
PAS ≤ 100 mmHg	1
Alteração do nível de consciência	1

FR ≥ 22 | PAS ≤ 100 | alteração mental

Pacote da 1ª hora: medir, cultivar, antibiótico, volume e vasopressor se preciso.

Hour-1 Bundle (SSC)

Primeira hora

- 1 Lactato (repetir se > 2)
- 2 Hemoculturas antes do ATB
- 3 Antibiótico IV amplo precoce
- 4 Cristalóide 30 mL/kg se hipotensão/lactato ≥ 4
- 5 Vasopressor se PAM < 65 após volume

Antibiótico após culturas, sem atrasar se gravidade

Definições Sepsis-3

Lembre - Definições Sepsis-3

Sepse = infecção + disfunção orgânica (9E40`A "e 2). Choque séptico = sepse + vasopressor para PAM "e 65 e lactato > 2 mmol/L apesar de volume adequado.

SOFA — ideia dos sistemas

Sistema | Marcador clássico

Respiratório | PaO₂/FiO₂

Coagulação | Plaquetas

Hepático | Bilirrubina

Cardiovascular | PAM / dose de vasopressor

SNC | ECG Glasgow

Renal | Creatinina / débito urinário

Metas iniciais de prova

- PAM "e 65 mmHg (noradrenalina 1ª linha no choque)
- Reavaliar volume com perfusão (lactato, tempo de enchimento, débito urinário)
- Controle de foco (dreno, retirada de cateter, cirurgia)
- Corticoide (hidrocortisona) se choque refratário

Não atrase antibiótico

Atencao - Não atrase antibiótico

Em choque séptico, ATB na 1ª hora. Culturas preferenciais, mas não atrasam tratamento se o paciente estiver grave.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.
www.medhubr1.com.br - MedHub R1